

Aanbevelingsgedrag van zorgverleners over kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap: resultaten van een bevraging

5 mei 2026

I. Peeters • A. Litzroth • C. Mazagatos Ateca • L. Cornelissen

DANKWOORD

We willen onze dank betuigen aan L. De Brabandere, G. Hendrickx en K. Maertens (Universiteit Antwerpen) voor hun waardevolle bijdrage aan de uitwerking van de studie en het inhoudelijke bijsturen van de vragenlijsten. Daarnaast danken we H. Jonker voor de input met betrekking tot de visualisatie van de resultaten.

Met de financiële steun van



SAMENVATTING

Taalbarrière, tijdsgebrek en gebrek aan communicatietechnieken vormen de belangrijkste drempels voor zorgverleners om kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap aan te bevelen.

Kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap biedt een effectieve bescherming tegen ernstige infecties bij jonge zuigelingen, voor de basisvaccinatie op acht weken leeftijd kan starten. Ondanks het gratis beschikbaar gestelde vaccin blijven er uitgesproken regionale verschillen in vaccinatiegraad bestaan, die zich weerspiegelen in het aantal gevallen van kinkhoest bij jonge zuigelingen. Dit onderzoek analyseert het aanbevelingsgedrag van zorgverleners met betrekking tot kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap en tracht mogelijke drempels voor het aanbevelen te identificeren.

97% van de bevroagde zorgverleners beveelt kinkhoestvaccinatie aan

In totaal namen 491 gynaecologen en huisartsen deel aan de bevraging, met een goede regionale spreiding. Dit komt neer op deelname van 1% van de huisartsen en 9% van de gynaecologen in België. Van de respondenten gaven 476 zorgverleners (97%) aan vaak of altijd vaccinatie aan te bevelen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met mogelijke selectiebias, aangezien vaccinatie-gezinde zorgverleners waarschijnlijk meer geneigd waren om deel te nemen.

Taalbarrière, tijdsgebrek en gebrek aan communicatietechnieken vormen de belangrijkste drempels

De voornaamste drempels in alle regio's zijn taalbarrières (belemmerend voor 55% van de zorgverleners in Vlaanderen, 41% in Wallonië en 62% in Brussel) en tijdsgebrek in het consult (respectievelijk 35%, 43% en 52%). Daarnaast vormt een gebrek aan communicatietechnieken of kennis om te kunnen omgaan met weerstand of moeilijke vragen over vaccinatie voornamelijk in Wallonië (47%) en Brussel (46%) een drempel (tegenover 22% in Vlaanderen).

Ook de verwachting dat een andere zorgverlener de vaccinatie zal opnemen belemmert in alle regio's het aanbevelen of bespreken van de vaccinatie (25% in Vlaanderen, 22% in Wallonië en 26% in Brussel).

Complexe procedures in Wallonië en Brussel resulteren in een beperkte toegang tot het gratis beschikbare kinkhoestvaccin en belemmeren de vaccinatiegraad

In Wallonië (15%) en Brussel (22%) belemmeren praktische aspecten zoals bestelling, bewaring, voorraadbeheer en registratie van het vaccin het aanbevelen van de vaccinatie. In Vlaanderen wordt dit minder frequent als drempel aangehaald (5%). Tegelijkertijd geven zorgverleners in Wallonië en Brussel aan minder frequent gebruik te maken van het gratis beschikbare vaccin (respectievelijk 38% en 51%), dan in Vlaanderen (99%).

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	5
1.1. Achtergrond	5
1.2. Doelstellingen	5
2. Methoden	5
3. Resultaten	6
3.1. Kenmerken van de zorgverleners.....	6
3.1.1. Kenmerken van alle deelnemende zorgverleners	6
3.1.2. Kenmerken in relatie tot het al dan niet aanbevelen van vaccinatie	7
3.2. Drempels van zorgverleners.....	8
3.2.1. Drempels bij niet aanbevelende zorgverleners	8
3.2.2. Drempels bij alle deelnemende zorgverleners	8
3.3. Praktische aanpak van de vaccinatie	11
3.3.1. Zelf vaccineren of verwijzen	11
3.3.2. Voorschrijfgedrag bij verwijzing voor vaccinatie	11
3.3.3. Voorschrijfgedrag op basis van terugbetalingsgegevens.....	12
4. Discussie	13
5. Actiepunten	14
6. Referenties	14
7. Bijlage	16

1. Inleiding

1.1. Achtergrond

Jonge zuigelingen, voornamelijk onder de leeftijd van zes maanden, vormen de belangrijkste risicogroep voor het ontwikkelen van ernstige kinkhoest. Vaccinatie vermindert het risico op ernstige symptomen en is opgenomen in het basisvaccinatieschema in België, dat start op de leeftijd van acht weken (1). Daarnaast beveelt de Hoge Gezondheidsraad sinds 2013 ook systematische vaccinatie tegen kinkhoest aan tijdens elke zwangerschap, ter bescherming van de allerjongste zuigelingen met maternale antistoffen (2). Deze vaccinatie wordt uitgevoerd met het gecombineerde difterie-tetanus-kinkhoestvaccin (Boostrix®) en wordt in alle regio's gratis ter beschikking gesteld aan zwangere vrouwen mits de arts het vaccin bestelt via het vaccinatieplatform. In Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel via Vaccinet (Departement Zorg) en in Franstalig België via eVax (ONE, Office de la Naissance et de l'Enfance).

De meest recente vaccinatiegraadgegevens (2019) tonen een hoge vaccinatiegraad voor de basisvaccins (98% voor 3^e dosis DTP), maar aanzienlijke regionale verschillen in vaccinatiegraad voor de maternale vaccinatie. In Vlaanderen werd een vaccinatiegraad van 85% bereikt, tegenover 39% in Wallonië en 31% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3). Dit leek weerspiegeld in de incidentie van kinkhoestgevallen jonger dan twee maanden tijdens de kinkhoestepidemie in 2024, waarbij in Wallonië en Brussel drie keer zoveel gevallen werden gerapporteerd dan in Vlaanderen (4).

Studies tonen aan dat patiënten hun arts vertrouwen wat betreft vaccinatieadvies (5,6). Daarnaast geeft een KCE-rapport over prenatale zorg aan dat in 2016 99,5% van de zwangere vrouwen minstens één keer een gynaecoloog consulteerde terwijl tussen 55% en 88% (met uitgesproken regionale verschillen) minstens één keer een huisarts raadpleegde (7). Hoewel het rapport benadrukt dat het prenatale zorgpad in België onvoldoende duidelijk is wat betreft rolverdeling, onderstreept het tegelijkertijd dat zowel gynaecologen als huisartsen een cruciale rol spelen in het aanbevelen en aanbieden van vaccinatie aan zwangere vrouwen. Om meer inzicht te krijgen in de houding van gynaecologen en huisartsen tegenover kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap werd een korte bevraging uitgevoerd door de dienst Epidemiologie van Infectieziekten van Sciensano. In dit rapport presenteren we de resultaten van deze bevraging.

1.2. Doelstellingen

In dit onderzoek probeerden we via een online bevraging bij huisartsen en gynaecologen, actief in prenatale zorg in België, te achterhalen (A) wat hun aanbeveling is voor kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap, (B) wat mogelijke drempels tot aanbeveling zijn en (C) wat de concrete aanpak voor vaccinatie is (welk vaccin wordt gebruikt en of er verwezen wordt naar een andere zorgverlener voor de vaccinatie). De resultaten van deze korte bevraging kunnen worden gebruikt om gerichtere acties op te zetten om de vaccinatiegraad in Brussel en Wallonië te verbeteren.

2. Methoden

Een vragenlijst werd opgesteld op basis van een door ECDC beschikbaar gestelde tool voor het bevorderen van vaccinatieacceptatie en -uptake, gebaseerd op het 5C model (8). Deze tool werd aangepast aan de Belgische context en aan onze doelgroep. De bevraging werd online ter beschikking gesteld via LimeSurvey van 15 oktober 2025 tot en met 15 december 2025 (9). De antwoorden werden gespeudonimiseerd verzameld, anoniem verwerkt en waren uitsluitend toegankelijk voor de betrokken onderzoekers. De vragenlijst bestond uit tien vragen en nam ongeveer drie minuten in beslag (zie bijlage 1). De vragenlijst werd verspreid via nieuwsbrieven en symposia van de betrokken beroepsverenigingen (Domus Medica, VVOG, SSMG, CMG, SMG, CrGOLF, ONE) en via de gefedereerde entiteiten (Vlaamse nieuwsbrief vaccinatoren, de infectieziekten flash en de website van Departement Zorg, AViQ en Vivalis). Daarnaast werden socialmediaposts gedeeld via LinkedIn-accounts en Sciensano om de deelname te bevorderen. Deelnemers werden gevraagd de info over het onderzoek te lezen en hun geïnformeerde toestemming te geven bij de aanvang van de vragenlijst. Ethische goedkeuring voor het uitvoeren van de studie werd verkregen van de ethische commissie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Enkel volledig ingevulde vragenlijsten werden meegenomen in de analyse.

3. Resultaten

3.1. Kenmerken van de zorgverleners

3.1.1. Kenmerken van alle deelnemende zorgverleners

In totaal namen 646 zorgverleners deel aan de bevraging, waarvan er 511 een volledig ingevulde vragenlijst inleverden. Hiervan gaven 491 zorgverleners (211 gynaecologen en 280 huisartsen) aan actief betrokken te zijn bij prenatale zorg in België en akkoord te gaan met deelname aan het onderzoek.

Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken van de deelnemende zorgverleners tegenover de verdeling in alle huisartsen en gynaecologen in België. Het merendeel bevond zich in de leeftijdsgroep 30-39 jaar (46%), werkte in groepspraktijken (49%) en was vrouw (83%). Ongeveer 52% van de zorgverleners was werkzaam in Vlaanderen, 30% in Wallonië en 16% in Brussel, wat in lijn is met de regionale bevolkingsverdeling en ook de regionale verdeling van alle gynaecologen en huisartsen in België. Belangrijk om mee te geven is dat de Brusselse zorgverleners voornamelijk in de Nederlandstalige gemeenschap werkzaam waren (namelijk 69 in de Nederlandstalige gemeenschap tegenover één in de Franstalige gemeenschap en negen zorgverleners in beide taalgemeenschappen). Daarnaast waren nog drie gynaecologen en één huisarts actief in zowel Vlaanderen als Brussel en drie zorgverleners in zowel Wallonië als Brussel. Van de deelnemende zorgverleners was 57% huisarts (193 in Vlaanderen, 66 in Wallonië en 20 in Brussel) en 43% gynaecoloog (65 in Vlaanderen, 81 in Wallonië en 62 in Brussel). Dit komt neer op deelname van 1% van de huisartsen en 9% van de gynaecologen in België.

Tabel 1. Leeftijd, gender, regio van professionele activiteit, beroep en werkomgeving van de 491 deelnemende zorgverleners die in de analyse werden opgenomen en vergelijking met de verdeling van alle huisartsen en gynaecologen in België*. (Bron: FOD Volksgezondheid (10))

Kenmerken	Deelnemers bevraging n (%)	Verdeling gynaecologen in België * %	Verdeling huisartsen in België * %
Leeftijd			
<30	48 (9)	12	14
30-39 jaar	224 (46)	23	23
40-49 jaar	96 (20)	16	10
50-59 jaar	67 (14)	17	13
≥60 jaar	56 (11)	32	40
Gender			
<i>Ik zeg dit liever niet</i>	1 (0)		
Man	80 (16)	35	50
Vrouw	407 (83)	65	50
Niet gekend	3 (1)		
Regio			
Brussels Gewest	79 (16)	16	10
Vlaams Gewest	258 (52)	51	56
Waals Gewest	147 (30)	33	34
VL+BR	4 (1)		
WA+BR	3 (1)		
Beroep			
Gynaecoloog	211 (43)		
Huisarts	280 (57)		
Werkomgeving°			
Academisch ziekenhuis	56 (11)		
Groepspraktijk	238 (49)		
ONE	1 (0)		
Regionaal ziekenhuis	130 (27)		
Solo	64 (13)		
Niet gekend	2 (0)		
Totaal	491 (100)		

* Verwijst naar personen die op 31/12/2024 geregistreerd staan in de federale databank van gezondheidsbeoefenaars.

° Vele artsen werken in verschillende werkomgevingen. Een hoofdcategorie werd bepaald op basis van volgende prioriteit (academisch ziekenhuis > groepspraktijk > solopraktijk > ONE consultatie in Brussel > onbekend)

3.1.2. Kenmerken in relatie tot het al dan niet aanbevelen van vaccinatie

Tabel 2a geeft weer dat 97% (476/491) van de zorgverleners die deelnamen aan de bevraging kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap altijd of vaak aanbeveelt. Hier speelt vermoedelijk een selectiebias, aangezien zorgverleners die vaccinatie (frequent) aanbevelen waarschijnlijk meer overtuigd zijn van het belang van deze vaccinatie en ook eerder geneigd waren om aan de bevraging deel te nemen.

Tabel 2a. Eigenschappen (leeftijd, gender, regio van professionele activiteit, beroep en werkomgeving) van de deelnemende zorgverleners volgens aanbevelen van het kinkhoestvaccin in de zwangerschap.

	Zorgverleners die soms/zelden/nooit vaccinatie aanbevelen		Zorgverleners die altijd/vaak vaccinatie aanbevelen		Onbekend	Totaal		Fisher's exact test
	n	(%)	n	(%)	n	N	(%)	p
Leeftijd								0,056
<30	1	(2)	47	(98)	.	48	(100)	
30-39 jaar	3	(1)	221	(99)	.	224	(100)	
40-49 jaar	2	(2)	93	(97)	1	96	(100)	
50-59 jaar	5	(7)	62	(93)	.	67	(100)	
≥60 jaar	3	(5)	53	(95)	.	56	(100)	
Gender								0,403
Ik zeg dit liever niet	.	(0)	1	(100)	.	1	(100)	
Man	4	(5)	76	(95)	.	80	(100)	
Vrouw	10	(3)	396	(97)	1	407	(100)	
Niet gekend	.	(0)	3	(100)	.	3	(100)	
Regio								0,059
Brussels Gewest	1	(1)	78	(99)	.	79	(100)	
Vlaams Gewest	4	(2)	254	(98)	.	258	(100)	
Waals Gewest	9	(6)	137	(93)	1	147	(100)	
VL+BR	.	(0)	4	(100)	.	4	(100)	
WA+BR	.	(0)	3	(100)	.	3	(100)	
Beroep								0,665
Gynaecoloog	6	(3)	204	(97)	1	211	(100)	
Huisarts	8	(3)	272	(97)	.	280	(100)	
Werkomgeving								0,662
Academisch ziekenhuis	2	(4)	54	(69)	.	56	(100)	
Groepspraktijk	6	(3)	232	(97)	.	238	(100)	
ONE	.	(0)	1	(100)	.	1	(100)	
Regionaal ziekenhuis	3	(2)	126	(97)	1	130	(100)	
Solo	3	(5)	61	(95)	.	64	(100)	
Niet gekend	.	(0)	2	(100)	.	2	(100)	
Totaal	14	(3)	476	(97)	1	491	(100)	

De 14 zorgverleners die aangaven nooit, zelden of soms kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap aan te bevelen, waren verspreid over de verschillende leeftijdsgroepen en regio's. Niet aanbevelende

zorgverleners lijken frequenter in de oudere leeftijdsgroepen en in Wallonië, alhoewel (net) niet significant volgens de dubbelzijdige Fisher's exact test met 0,05 drempel (respectievelijk $p=0,056$ en $p=0,059$). Opmerkelijk is dat twee van de niet-aanbevelende zorgverleners werkzaam waren in een academisch ziekenhuis, respectievelijk één in Wallonië en één in Brussel.

Tabel 2b geeft dezelfde gegevens weer, maar zonder zorgverleners die in verschillende regio's werken of een onbekend aanbevelingsprofiel hebben. Daarnaast werden alle zorgverleners herverdeeld in twee leeftijdsgroepen 'jonger dan 50 jaar' en '50 jaar en ouder'. Met deze herschikking van de data, zijn niet-aanbevelende zorgverleners significant frequenter in de leeftijdsgroep '50 jaar en ouder' en in Wallonië volgens de dubbelzijdige Fisher's exact test met 0,05 drempel (respectievelijk $p=0,011$ en $p=0,027$).

Tabel 2b. Eigenschappen (leeftijd en regio van professionele activiteit) van de deelnemende zorgverleners volgens aanbevelen van het kinkhoestvaccin in de zwangerschap*

	<i>Zorgverleners die soms/ zelden/ nooit vaccinatie aanbevelen</i>		<i>Zorgverleners die altijd/ vaak vaccinatie aanbevelen</i>		Totaal		Fisher's exact test
	n	(%)	n	(%)	N	(%)	p
Leeftijd							0,011
<50	6	(2)	351	(98)	357	(100)	0,027
≥50	8	(7)	114	(93)	122	(100)	
Regio							
Brussels Gewest	1	(1)	77	(99)	78	(100)	
Vlaams Gewest	4	(2)	252	(98)	256	(100)	
Waals Gewest	9	(6)	136	(94)	145	(100)	
Totaal	14	(3)	465	(97)	479	(100)	

* Zorgverleners die in verschillende regio's werken of een onbekend aanbevelingsprofiel hebben, zijn niet opgenomen in de cijfers.

3.2. Drempels van zorgverleners

3.2.1. Drempels bij niet aanbevelende zorgverleners

De 14 zorgverleners die kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap soms, zelden of nooit aanbevelen geven als frequentste belemmerende factoren: 'gebrek aan communicatietechnieken of kennis om te kunnen omgaan met weerstand of moeilijke vragen over vaccinatie', 'onzekerheid of het gebruik van het vaccin in de zwangerschap toegestaan is volgens de bijsluiter', 'tijdsgebrek in de consultatie', 'onvoldoende kennis over de richtlijnen of aanbevelingen', onzekerheid over de doeltreffendheid om de pasgeborene te beschermen' en 'taalbarrière bij de zwangere vrouw'.

3.2.2. Drempels bij alle deelnemende zorgverleners

Figuur 1 geeft de drempels voor het aanbevelen van de kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap weer bij alle deelnemende zorgverleners. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het voornamelijk drempels van zorgverleners betreft die vaccinatie wel aanbevelen. De belangrijkste drempels in alle regio's zijn 'taalbarrière bij de zwangere vrouw' (als belemmerend aangegeven door 55% van de Vlaamse, 41% van de Waalse en 62% van de Brusselse zorgverleners) en 'tijdsgebrek tijdens de consultatie' (respectievelijk 35%, 43% en 52%).

Daarnaast vormt een 'gebrek aan communicatietechnieken of kennis om om te gaan met weerstand of moeilijke vragen over vaccinatie' een frequentere drempel voor Waalse (47%) en Brusselse zorgverleners (46%) dan voor Vlaamse zorgverleners (22%).

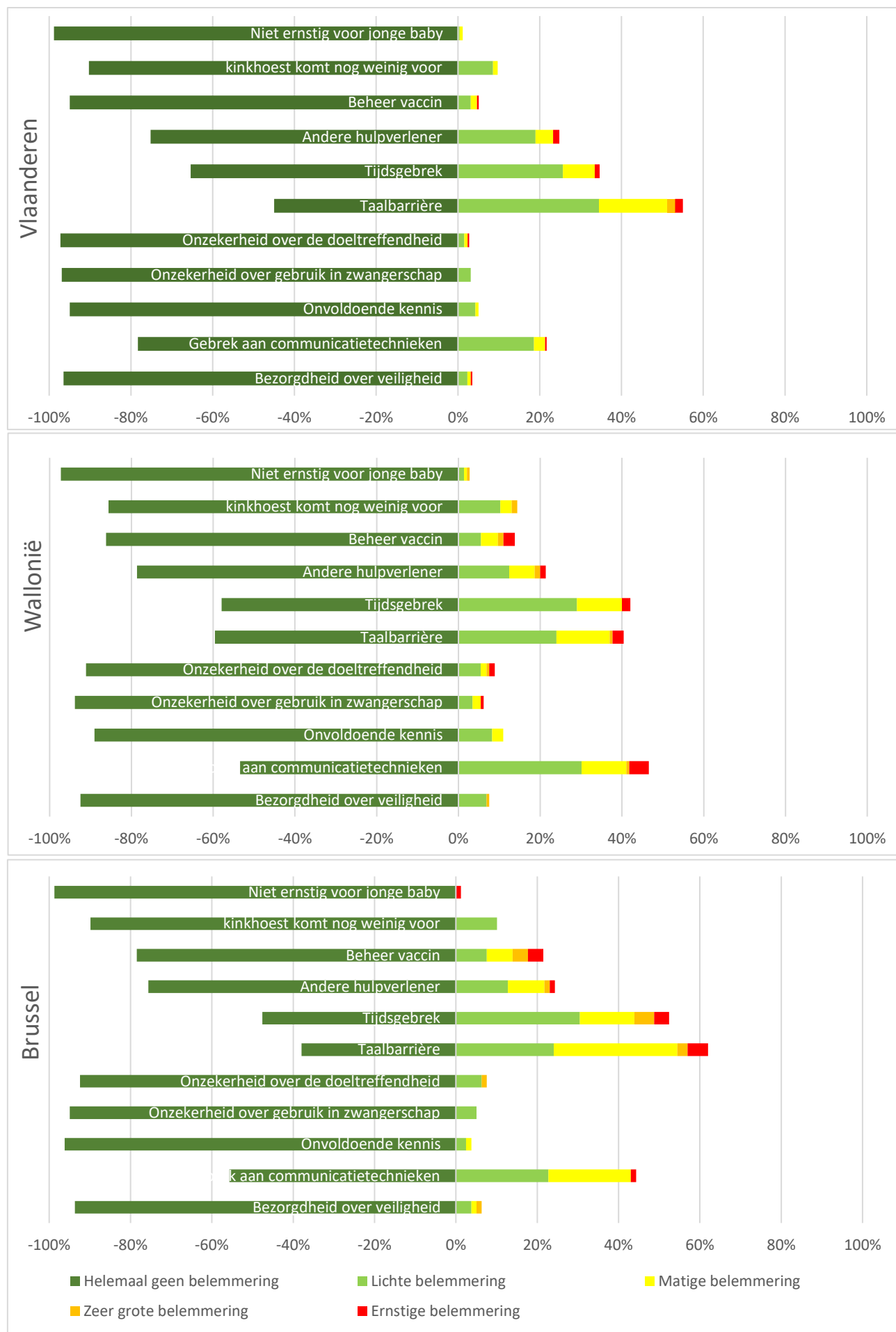
De 'verwachting dat een andere hulpverlener vaccinatie zal opnemen' speelt in alle regio's een rol (als belemmerend aangegeven door 25% van de Vlaamse, 22% Waalse en 26% van de Brusselse zorgverleners).

Met betrekking tot 'praktische aspecten zoals bestelling, bewaring, voorraadbeheer en registratie van het vaccin' zien we voornamelijk in Brussel (22%) en Wallonië (15%) een drempel ervaren, in vergelijking met Vlaanderen (5%).

In Bijlage 1 worden de odds ratio's en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor verschillende drempels per regio (met Vlaanderen als referentie) weergegeven. Deze analyse bevestigt bovenstaande bevindingen en toont aan dat taalbarrière significant minder vaak als drempel wordt gerapporteerd in Wallonië dan in Vlaanderen. Tijdsgedbrek in het consult wordt daarentegen significant vaker als drempel aangegeven in Brussel in vergelijking met Vlaanderen. Gebrek aan communicatietechnieken of kennis om te kunnen omgaan met weerstand of moeilijke vragen over vaccinatie komt zowel in Brussel als in Wallonië significant vaker naar voor als drempel, net als problemen met de praktische aspecten van het vaccinatiebeheer.

Als bijkomende drempel geven 23 huisartsen (voornamelijk in Wallonië) aan dat de zwangerschapsopvolging voornamelijk via de gynaecoloog verloopt. Ook geven negen huisartsen (voornamelijk in Wallonië) aan dat de gynaecoloog kinkhoestvaccinatie niet aanbeveelt.

Figuur 1. Belang van drempels bij zorgverleners voor het aanbevelen van het kinkhoestvaccin in de zwangerschap, per regio. (bij gecombineerde regio's of indien de ernst van de drempel onbekend was werd deze niet weergegeven)



3.3. Praktische aanpak van de vaccinatie

3.3.1. Zelf vaccineren of verwijzen

Gynaecologen in Vlaanderen verwijzen zwangere vrouwen meestal door voor vaccinatie, terwijl gynaecologen in Brussel en Wallonië meer zelf vaccineren (tabel 3).

Tabel 3. Praktische aanpak van de kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap aangegeven door de aanbevelende artsen, per regio.

	Vlaanderen				Wallonië				Brussel			
	Gynaecoloog		Huisarts		Gynaecoloog		Huisarts		Gynaecoloog		Huisarts	
	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)
<i>Ik vaccineer zelf.</i>	12	(18)	190	(98)	69	(85)	61	(95)	53	(87)	16	(90)
<i>Ik verwijz de patiënt naar een andere zorgverlener.</i>	53	(82)	1	(1)	11	(14)	3	(5)	7	(11)	2	(10)
<i>Niet relevant, ik raad de vaccinatie bijna nooit aan.</i>	0	(0)	1	(1)	1	(1)	0	(0)	1	(2)	0	(0)
<i>Totaal</i>	65	(100)	192	(100)	81	(100)	64	(100)	61	(100)	18	(100)

In Vlaanderen wordt bijna altijd gebruik gemaakt van het gratis beschikbaar gestelde vaccin, waar in Wallonië en Brussel frequent een vaccin wordt gebruikt dat de zwangere vrouw zelf heeft aangekocht (tabel 4).

Tabel 4. Gebruik van een kinkhoestvaccin tijdens de zwangerschap bij het zelf vaccineren, per regio.

	Vlaanderen				Wallonië				Brussel			
	Gynaecoloog		Huisarts		Gynaecoloog		Huisarts		Gynaecoloog		Huisarts	
	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)
<i>Ik gebruik een gratis beschikbaar gesteld vaccin.</i>	12	(100)	188	(98)	30	(43)	20	(33)	28	(54)	7	(44)
<i>Ik gebruik een vaccin dat de zwangere vrouw zelf aangekocht.</i>	0	(0)	1	(1)	39	(57)	41	(67)	24	(46)	8	(50)
<i>Onbekend</i>	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(6)
<i>Totaal</i>	12	(100)	190	(100)	69	(100)	61	(100)	52	(100)	16	(100)

3.3.2. Voorschrijfgedrag bij verwijzing voor vaccinatie

Artsen die verwijzen voor de kinkhoestvaccinatie in Vlaanderen gaan er eerder vanuit dat de andere zorgverlener het vaccin op voorraad heeft. In Wallonië en Brussel wordt het vaccin vaker voorgeschreven (Tabel 5). Belangrijk hier is dat het voor Wallonië en Brussel slechts een klein aantal artsen betreft die verwijzen voor vaccinatie.

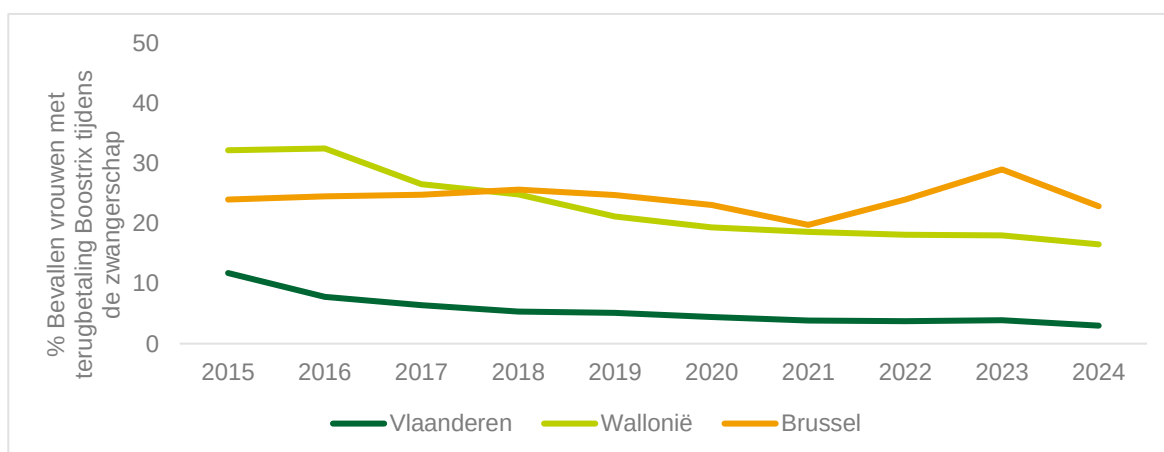
Tabel 5. Voorschrijfgedrag van artsen die verwijzen voor kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap, per regio.

	Vlaanderen				Wallonië				Brussel			
	Gynaecoloog		Huisarts		Gynaecoloog		Huisarts		Gynaecoloog		Huisarts	
	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)	<i>n</i>	(%)
<i>Ik ga ervan uit dat de andere zorgverlener het gratis vaccin op voorraad heeft .</i>	49	(94)	1	(100)	1	(9)	1	(33)	4	(57)	2	(100)
<i>Ik schrijf het kinkhoestvaccin voor.</i>	3	(6)	0	(0)	10	(91)	2	(67)	3	(43)	0	(0)
<i>Onbekend</i>	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Totaal	52	(100)	1	(100)	11	100	3	(100)	7	(100)	2	(100)

3.3.3. Voorschrijfgedrag op basis van terugbetalingsgegevens

Volgens gegevens van het Intermutualistische Agentschap (IMA), dat beschikt over de terugbetalingsgegevens van een representatieve steekproef van de Belgische populatie, ligt de proportie bevallen vrouwen die een Boostrix-vaccin terugbetaald krijgen gedurende de ganse periode 2015-2024 lager in Vlaanderen (3-12%) dan in Wallonië (16-32%) en 23% in Brussel (20-29%) (Figuur 2). Dit suggereert dat minder gebruik wordt gemaakt van het gratis beschikbare vaccin in Wallonië en Brussel.

Figuur 2. Proportie van bevallen vrouwen die tijdens de zwangerschap een Boostrix vaccin kreeg terugbetaald, per regio. (Bron: representatieve steekproef Intermutualistische Agentschap)



4. Discussie

Aan de bevraging van gynaecologen en huisartsen over kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap namen 491 gynaecologen en huisartsen, of 1% van de Belgische huisartsen en 9% van de Belgische gynaecologen, deel met een regionaal representatieve spreiding.

Het hoge percentage artsen (97%) dat kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap aanbeveelt, kan waarschijnlijk mede verklaard worden door selectiebias. We veronderstellen immers dat artsen die vaccinatie belangrijk vinden meer geneigd waren aan dit onderzoek deel te nemen. Tevens werd de rekrutering voornamelijk via nieuwsbrieven en symposia van beroepsverenigingen gedaan waarmee vermoedelijk eerder artsen met hogere affiniteit voor evidence-based werken bereikt werden. Opvallend is dat voornamelijk vrouwen deelnamen aan de studie (83%). Dit is ook gekend uit de literatuur (11).

In alle regio's, maar voornamelijk in Brussel, zijn de belangrijkste drempels voor het aanbevelen van vaccinatie taalbarrière (als belemmerend aangegeven door 55% van de deelnemende hulpverleners in Vlaanderen, 41% in Wallonië 62% in Brussel) en tijdsgebrek in de consultatie (respectievelijk 35%, 43% en 52%). Daarnaast wordt gebrek aan communicatietechnieken en kennis om te kunnen omgaan met weerstand of moeilijke vragen over vaccinatie frequenter als een drempel ervaren in Brussel (46%) en Wallonië (47%) dan in Vlaanderen (22%). Onderzoek naar vaccinatievertrouwen bij zorgverleners toont aan dat er een behoefte bestaat aan online toegankelijke applicaties en websites met duidelijke informatie die gedeeld kan worden met patiënten, aan FAQ's en aan gerichte opleidingen om communicatie over vaccinatie te versterken (12). Het centraal aanbieden van overzichtelijke, meertalige en evidence-based informatie over het belang van maternale kinkhoestvaccinatie, met inbegrip van transparante communicatie over mogelijke nevenwerkingen, kan bijdragen aan het verlagen van de drempels taalbarrière en gebrek aan communicatietechnieken. Dit zou onder meer gerealiseerd kunnen worden door bestaande informatie beter te structureren, te vertalen en breder te verspreiden.

De veronderstelling dat een andere hulpverlener kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap zal opnemen, wordt in alle regio's aangegeven als een reden om vaccinatie niet aan te bevelen of te bespreken (25% in Vlaanderen, 22% in Wallonië en 26% in Brussel). Dit weerspiegelt een KCE-rapport waarin wordt aangegeven dat de rolverdeling binnen de prenatale opvolging tussen actoren onvoldoende duidelijk en bovendien regionaal verschillend is (7). De gedeelde verantwoordelijkheid van het aanbevelen en toedienen van kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen houdt het risico in dat geen enkele zorgverlener deze taak effectief opneemt, waardoor vaccinatie uiteindelijk niet wordt uitgevoerd. Een verduidelijking van de rolverdeling zou hierin verbetering kunnen brengen.

Ten slotte vormen de praktische aspecten, zoals bestelling, bewaring, voorraadbeheer en registratie van het vaccin, een duidelijk grotere drempel in Wallonië (15%) en Brussel (22%) dan in Vlaanderen (5%). Dit sluit aan bij de uitgesproken regionale verschillen die we zien in het toepassen van de kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap.

In Vlaanderen geven gynaecologen voornamelijk aan door te verwijzen voor vaccinatie (82%), en wordt er bij vaccinatie door alle zorgverleners bijna altijd gebruikgemaakt van gratis beschikking gestelde vaccins (99%). In Wallonië (85%) en Brussel (87%) daarentegen wordt vaccinatie vaker door gynaecologen zelf toegediend. Tegelijkertijd wordt in Wallonië en Brussel minder gebruikgemaakt van de gratis vaccins (respectievelijk 38% en 51%), en wordt het vaccin vaker voorgeschreven, waardoor de zwangere vrouw het zelf moet aankopen met slechts gedeeltelijke of geen terugbetaling (kostprijs voor de patiënt respectievelijk 6,5 of 25 €). Vereenvoudiging van deze praktische aspecten en gerichte ondersteunende maatregelen kunnen de toegang tot de gratis ter beschikking gestelde vaccins in Wallonië en Brussel verbeteren.

5. Actiepunten

Op basis van deze resultaten werden, in overleg met de betrokken beroepsverenigingen en gefedereerde entiteiten, de volgende actiepunten geformuleerd. Deze zijn gericht op het reduceren van de voornaamste drempels bij zorgverleners in het aanbevelen van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap.

A. Taalbarrière, tijdsgebrek en gebrek aan communicatietechnieken en kennis:

- Vereenvoudigen van het gesprek over kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap door de zorgverlener, via een communicatie waarin naar de bestaande informatiebrochures wordt verwezen ([Departement Zorg](#) en [ONE](#)).
- Informeren over de beschikbaarheid in 7 talen van de brochures van Departement Zorg (Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Oekraïens, Russisch, Turks) en inzetten op meertalige brochures door ONE.
⇒ Verantwoordelijkheid: deelstaten.

B. Veronderstelling dat een andere hulpverlener vaccinatie zal opnemen:

- Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners tijdens de zwangerschap verbeteren door een efficiënt vaccinatieregister, toegankelijk voor alle zorgverleners in alle regio's.
⇒ Verantwoordelijkheid: deelstaten
- Benadrukken van het gebruik van een gestandaardiseerde “checklist zwangerschap en voorbereiding op de geboorte” door de beroepsverenigingen voor gebruik door alle betrokken zorgverleners (vb. [Checklist Kind&Gezin](#) en info in zwangerschapsboekjes), waarbij kinkhoestvaccinatie systematisch besproken wordt bij de aanvang van het 2^e trimester.
⇒ Verantwoordelijkheid: beroepsverenigingen

C. Regionale verschillen in gebruik gratis vaccin:

- Het verbeteren van de beschikbaarheid van het gratis kinkhoestvaccin in Brussel en Wallonië door ziekenhuizen actief te informeren over de mogelijkheid tot het aanleggen van een vaccinstock (via e-vax bestellingen) .
⇒ Verantwoordelijkheid: ONE
- Het duidelijk communiceren naar prenatale zorgverleners over de voorwaarden voor gratis vaccinatie in de Franstalige gemeenschap, evenals de bestaande terugbetalingsmechanismen (inclusief verwijzingsrichtlijnen naar locaties waar het vaccin gratis beschikbaar is).
⇒ Verantwoordelijkheid: franstalige gemeenschap

6. Referenties

1. Hoge Gezondheidsraad. Hoge Gezondheidsraad [Internet]. [cited 2026 Feb 9]. Advies basisvaccinatieschema. Available from: <https://www.hgr-css.be/nl/advies/9606/basisvaccinatieschema>
2. SHC. Hoge Gezondheidsraad [Internet]. 2020 [cited 2026 Jan 29]. Superior Health Council- Maternal Immunisation. Available from: <https://www.hgr-css.be/nl/advies/8754/immunisatie-tijdens-de-zwangerschap>
3. Grammens. sciensano.be [Text] [Internet]. 2022 [cited 2026 Jan 29]. Vaccinatiegraad van basisvaccinaties (Dutch). Available from: <https://www.sciensano.be/en/biblio/vaccinatiegraad-van-basisvaccinaties>
4. Peeters et al. Disparities in maternal vaccination and infant pertussis in Belgium [Internet]. 2025 [cited 2026 Jan 29]. Available from: https://www.sciensano.be/sites/default/files/maternal_vaccination_escmid_vaccine_2025_ip_-_copy.pdf
5. European Commission. Europeans' attitudes towards vaccination (Special Eurobarometer 488). [Internet]. 2019 [cited 2026 Jan 29]. Available from: https://health.ec.europa.eu/system/files/2019-04/20190426_special-eurobarometer-sp488_en_0.pdf
6. European Commission. Attitudes on vaccination against COVID-19 (Flash Eurobarometer 2692). [Internet]. 2022 [cited 2026 Jan 29]. Available from: <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2692>
7. Benahmed N. Towards integrated antenatal care for low-risk pregnancy [Internet]. 2019;HSR: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). doi:D/2019/10.273/7
8. European Centre for Disease Prevention and Control. Tools and methods for promoting vaccination acceptance and uptake: a social and behavioural science approach [Internet]. 2025 [cited 2026 Feb 11]. Available from: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tools-and-methods-promoting-vaccination-acceptance-and-uptake>
9. LimeSurvey — Free Online Survey Tool [Internet]. [cited 2026 Mar 31]. Available from: <https://www.limesurvey.org/>
10. Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. FOD Volksgezondheid [Internet]. 2025 [cited 2026 Feb 18]. Gedetailleerde statistieken van beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België volgens leeftijd, geslacht, gewest en provincie op 31/12/2024. Available from: <https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/hwf-statan-2024-detailstatistieken>
11. Listyowardojo TA, Nap RE, Johnson A. Demographic differences between health care workers who did or did not respond to a safety and organizational culture survey. BMC Res Notes. 2011 Sep 7;4:328. doi:10.1186/1756-0500-4-328 PubMed PMID: 21899771; PubMed Central PMCID: PMC3180706.
12. De Waele A, Hendrickx G, Valckx S, Domínguez À, Toledo D, Castilla J, et al. The Vaccine Training Barometer: Assessing healthcare providers' confidence to answer vaccine-related questions and their training needs. Vaccine. 2024 Apr;42(9):2421–8. doi:10.1016/j.vaccine.2024.02.078

7. Bijlage

Bijlage 1. Vragenlijst

Kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap

Om de resultaten van dit onderzoek beter te kunnen interpreteren, stellen we u enkele algemene vragen over uzelf en uw professionele achtergrond. Deze gegevens worden volledig anoniem verwerkt en enkel gebruikt voor wetenschappelijke analyse. Uw antwoorden helpen ons om eventuele verschillen tussen beroepsgroepen, regio's of werkcontexten beter te begrijpen.

1. Hoe oud bent u? (Kies één van de volgende antwoorden)
 - <30 jaar
 - 30-39 jaar
 - 40-49 jaar
 - 50-59 jaar
 - ≥60 jaar
2. Wat is uw gender? (Kies één van de volgende antwoorden)
 - Man
 - Vrouw
 - Ik zeg dit liever niet
3. Wat is uw huidige beroep? (Kies één van de volgende antwoorden)
 - Huisarts
 - Gynaecoloog
4. In welk(e) gewest(en) werkt u? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 - Vlaams Gewest
 - Waals Gewest
 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
5. Welke van onderstaande beschrijft uw werkomgeving het best? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 - Solopraktijk
 - Groepspraktijk
 - Regionaal ziekenhuis
 - Academisch ziekenhuis
 - Prenatale consulten ONE
 - Anders:...

In dit onderdeel peilen we naar uw praktijkvoering rond kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. Zo krijgen we een algemeen beeld van wat er leeft onder zorgverleners. Uw antwoorden helpen ons om mogelijke informatie- of ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen, met het oog op praktijkverbetering.

6. Beveelt u kinkhoestvaccinatie aan bij zwangere vrouwen? (Kies één van de volgende antwoorden)
 - Nooit
 - Zelden
 - Soms
 - Vaak
 - Altijd
7. Belemmeren onderstaande factoren u persoonlijk bij het aanbevelen van de kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap?(geef elke factor een score van 1= helemaal geen belemmering tot 5= zeer grote belemmering).

	1	2	3	4	5
Bezorgdheid over de veiligheid van het vaccin.					
Onvoldoende kennis over de richtlijnen of aanbevelingen.					

	1	2	3	4	5
Onzekerheid of het gebruik van het vaccin in de zwangerschap toegestaan is volgens de bijsluiter.					
Onzekerheid over de doeltreffendheid om de pasgeborene te beschermen.					
De indruk dat kinkhoest nog weinig voorkomt.					
De indruk dat kinkhoest meestal niet ernstig is voor jonge baby's.					
Gebrek aan communicatietechnieken of kennis om om te gaan met weerstand of moeilijke vragen over vaccinatie.					
Taalbarrière bij zwangere vrouwen.					
Tijdsgebrek in de consultatie.					
Verwachting dat een andere hulpverlener dit opneemt.					
Praktische aspecten zoals bestelling, bewaring, voorraadbeheer en registratie van het vaccin.					

8. Indien er voor u een andere belangrijke reden is die hierboven nog niet werd vermeld, kan u die dan kort beschrijven:
9. In welke mate belemmert deze bijkomende factor u persoonlijk bij het aanbevelen van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap? (geef elke factor een score van 1= helemaal geen belemmering tot 5= zeer grote belemmering).
10. Wanneer u het kinkhoestvaccin tijdens de zwangerschap aanbeveelt, wat is dan uw praktische aanpak? (Kies één van de volgende antwoorden)
 - a) Ik vaccineer zelf of laat een gekwalificeerde medewerker binnen mijn werkomgeving vaccineren.
 - b) Ik verwijs de patiënt naar een andere zorgverlener buiten mijn werkomgeving voor vaccinatie.
 - c) Niet relevant, ik raad de vaccinatie bijna nooit aan.

Indien a), welke van de volgende situaties is het meest op u van toepassing? (Kies één van de volgende antwoorden)

- Ik gebruik een gratis vaccin (verkregen via ONE of Departement Zorg/Vaccinnet), beschikbaar in mijn werksetting.
- Ik gebruik een vaccin dat de zwangere vrouw zelf in de apotheek heeft aangekocht.

Indien b), welke van de volgende situaties is het meest op u van toepassing? (Kies één van de volgende antwoorden)

- Ik schrijf het kinkhoestvaccin voor, zodat de patiënte dit in de apotheek kan aankopen.
- Ik ga ervan uit dat de andere zorgverlener het gratis vaccin (verkregen via ONE of Departement Zorg/Vaccinnet), op voorraad heeft of het vaccin zal voorschrijven.

Bijlage 2. Odds ratio's (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen voor het voorkomen van drempels per regio (Brussel en Wallonië tegenover Vlaanderen).

Drempel*	Regio	OR (95% CI)
<i>Bezorgdheid over veiligheid</i>	Brussel	1,9 (0,6-5,8)
	Wallonië	2,3 (0,9-5,6)
<i>Gebrek aan communicatietechnieken</i>	Brussel	2,9 (1,7-4,9)
	Wallonië	3,1 (2,0-4,9)
<i>Onvoldoende kennis</i>	Brussel	0,7 (0,2-2,7)
	Wallonië	2,3 (1,1-5,0)
<i>Onzekerheid over gebruik in zwangerschap</i>	Brussel	1,7 (0,5-5,7)
	Wallonië	2,1 (0,8-5,4)
<i>Onzekerheid over de doeltreffendheid</i>	Brussel	2,9 (1,0-9,0)
	Wallonië	3,5 (1,4-9,0)
<i>Taalbarrière</i>	Brussel	1,3 (0,8-2,2)
	Wallonië	0,6 (0,4-0,8)
<i>Tijdsgebrek</i>	Brussel	2,1 (1,3-3,6)
	Wallonië	1,4 (0,9-2,1)
<i>Andere hulpverlener</i>	Brussel	1,0 (0,5-1,8)
	Wallonië	0,8 (0,5-1,3)
<i>Beheer vaccin</i>	Brussel	5,1 (2,4-11,2)
	Wallonië	3,0 (1,4-6,2)
<i>kinkhoest komt nog weinig voor</i>	Brussel	1,1 (0,5-2,4)
	Wallonië	1,6 (0,8-2,9)
<i>Niet ernstig voor jonge baby</i>	Brussel	1,1 (0,1-10,6)
	Wallonië	2,4 (0,5-10,8)

*Drempel gedefinieerd als het ervaren van lichte, matige, zeer grote of ernstige hinder;
geen drempel = helemaal geen hinder.

CONTACT

Ilse Peeters • T+32 2 642 54 92 • Ilse.peeters@sciensano.be

OVER SCIENSANO

Sciensano is een openbaar en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat zich inzet voor de gezondheid van mens en dier en hun omgeving.

We doen wetenschappelijk onderzoek en surveillance, en ondersteunen de overheid en verschillende agentschappen en organisaties met expertise, adviezen en diensten op vlak van gezondheid.

Sciensano hecht veel belang aan het One Health-principe, dat benadrukt dat de gezondheid van mens, dier en hun omgeving onderling verbonden zijn. Daarom is ons onderzoek interdisciplinair en integreert het verschillende invalshoeken.

Met meer dan duizend medewerkers en 120 jaar aan wetenschappelijke expertise, is Sciensano een gerenommeerd wetenschapsinstituut, dat deel uitmaakt van verschillende internationale wetenschappelijke netwerken.

MEER INFO

Sciensano.be – info@sciensano.be

Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11